随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

急性肾盂肾炎、急性膀胱炎　尿菌培养+

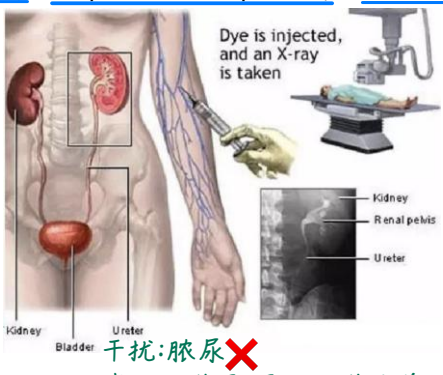
3.**真性细菌尿（急性尿感的金标准）：①清洁中段尿细菌培养≥10 万/ml；②清洁中段尿沉渣涂片细菌＞1 个/HP；**无污染
③膀胱穿刺尿细菌培养阳性

静脉打造影剂后模拟正常排尿过程①观察结构 ②观察分肾功能

4.**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU（慢性肾盂肾炎的金标准）**慢性-纤维化,胶原纤维收缩肾盂肾盏缩窄变形

肾血供丰富,致病菌容易入血 不是尿白细胞↑,也不是尿液细菌培养+　存在于近端小管上皮细胞

5.多见于**肾盂肾炎**的检查：**血**白细胞和 C 反应蛋白升高、**血**液细菌培养阳性、**白细胞管型**、尿 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 NAG↑、尿 β_2-微球蛋白 β_2-MG↑、**输尿管导尿或**膀胱**冲洗后**尿培养阳性、**小管功能受损如尿比重和渗透压↓**



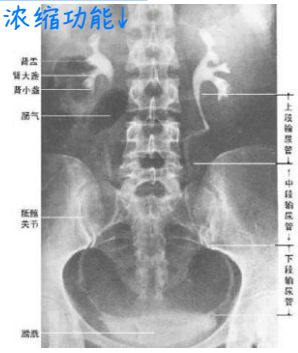
膀胱之前



洗干净膀胱

IVU

浓缩功能↓



干扰:脓尿 ✗
真性细菌尿,尿液细菌培养阳性 ✗
膀胱穿刺尿细菌培养阳性 ✗

检查分肾功能:肾图、CTU、IVU

五、急性尿感

可能可能最可能	急性膀胱炎 下尿路感染	急性肾盂肾炎 上尿路感染
膀胱/尿道刺激症（尿频、尿急、尿痛）	√	**可有可无** 炎症还未波及膀胱
全身症状（T＞38、血 WBC↑） 非尿中WBC	×	√
ttsx **肾区叩痛** 不见于肾盂积液	×	√
真性细菌尿 因为肾盂积液不累及肾脏包膜	√	√
明显脓尿	√	√
白细胞管型≠脓尿	×	√
留取尿细菌检查标本**后** ①**立即**开始治疗 ② ①先留标本再治 ②不用等药敏结果出来后再治	①年轻未孕女性：**3 日短程疗法** ②**免疫力低下、糖尿病、老年、妊娠、男性：7 日** 大部分是复杂性尿感 ③停抗生素 7 天后复查尿菌培养若仍阳性应继续治疗至 2 周 3日→1周→2周	①**2 周**（三膀二肾）用药72h无效应换药 ②复发（病原体与上次完全相同复婚）：6 周 型号一样 ③半年内发作 2 次以上：6 月 （长程低剂量抑菌） 2周→6周→6月
常用抗生素	①**磺胺类、β-内酰胺类（青霉素类如阿莫西林、头孢菌素类）、喹诺酮类**（除外莫西沙星）尿黄莫偷窥啊 G+:一二代头孢 G-:三代头孢(他定一曲噻哌酮) 尿中不能达到一个有效浓度 ②**急性膀胱炎的一线药：复方新诺明（磺胺甲恶唑+甲氧苄啶 SMZ-TMP）、呋喃妥因、匹美西林**（夫夫美） 杀菌 = 抑菌 + 抑菌	

妊娠不用磺胺,不用喹诺酮(孕妇、哺乳、18岁以下都不建议用喹诺酮) 此时用β-内酰胺类抗生素

急性肾盂肾炎的并发症：

①**肾乳头坏死**：体温再度升高，腰痛剧烈、**绞痛**（脱落的坏死组织阻塞输尿管）、血尿可伴败血症、感染性休克、急性肾衰竭

②肾盂积脓、肾周围脓肿

③尿源性脓毒血症：危险因素有**尿路梗阻**（最常见）、高龄、糖尿病、免疫抑制剂、留置导尿管、泌外手术

